

Flujograma de Pesquisa, Diagnostico, Tratamiento y Seguimiento de la Diabetes

Pesquisa DM2 -PNA

Diagnostico

Tratamiento

Mayores de 18 Años
(No Gestantes)

Búsqueda Activa Pacientes Diabéticos Referencia Contrareferencia Demanda Espontanea

NTN031A98

Test de Findrisk
- Leve (< o = a 11 puntos) consejería y control Anual.
- **Moderado/Alto** (> a 12 Puntos) programar atención medica proxima y solicitar GPA

Persona > 45 años o < de 45 con al menos 1 de los siguientes factores de riesgo
- Familiar 1° grado DM2
- Antecedentes de Diabetes Gestacional o Macrosomia Fetal GAA o TAG
- Sedentarismo
- Enfermedad Cerebro vascular
- Hipertensión Arterial
- HDL <35, TG> 250
- TBQ

RCV muy Alto 30% control en cada visita
RCV alto 20 a 30% control c/ 3 a 6 meses
RCV Moderado 10 a 20% Control c/ 6 a 12 meses
RCV bajo 10% Evaluación anual

NTN009K22
NTN010K22
NTN008K22
NTN007K22

Admisión
Datos Filiatorios de contacto, Obra Social, Plan Incluir Salud, Sumar, HSI

Enfermería
- Control Integral de salud HSI
- Toma de signos vitales
- Peso, Talla, TA, IMC
- Circunferencia Abdominal
- Circunferencia Cuello
- Cesación Tabaquica
- Psicoeducación
- Consejería en F.R.
Vacunación
*Influenza
*Neumococo
*Doble Adulto
*COVID

Control Medico Integral (1° Consulta)
- Llenado de HSI
- Registro de Cronicidad
- RCV
- Historia clínica, Motivo de Consulta, Examen Físico, Tratamiento actual, Problemas, Conductas, Diagnostico, Solicitud de interconsultas.
- Educación
- Turno Programado

Laboratorio
Hemograma completo - Glucemia - Urea Creatinina - Ionograma - IFGe - RACom Proteinuria CT, HDL, LDL, TG - Hemograma GOT - GPT - GGT - FAL - Orina Completa

Consulta de Diagnostico de Diabetes (2° Consulta)
-Solicitar nueva GPA
-Valorar resultados y Definir Conducta

CTC050A98-T89-T90

Glucemia Plasmáticas en ayunas (GPA) 100 a 125

Prueba de Tolerancia oral a la glucosa(PTOG)

141 a 199 mg/dl

PRE DIABETES

2° Glucemia Plasmáticas en ayunas (GPA) > o = a 126

> 200 mg/dl

DIABETES

Glucemia al azar > a 200 + Sintomas
-Poliuria
-Polidipsia
-Polifagia
-Perdida de Peso

TAT010A98

META HbA1C7
Considerar metas menos estrictas en episodios de hipoglucemia frecuentes/severas, complicaciones avanzadas, comorbilidades significativas, fragilidad, expectativa de vida < 10 años

LBL056VMD

No Farmacológico
Educación para el auto manejo (EDAM)
- Educación Física 30 Min/Día
- Alimentación Saludable
- Evitar consumo de Alcohol
- Higiene del Sueño
- Mantener Peso Adecuado
- No Fumar
- Cuidado bucal
- Evaluación salud mental / depresión

TAT032A98

COT023P22

Farmacológico

NTN032T89-T90

SIN Síntomas de Hiperglucemia
1- METFORMINA 500 mg/Día + EVS + EDAM + Evaluar FR
2- Al mes: METFORMINA 1000 mg/Día C/3 Meses: si no alcanza meta pese a buena adherencia a medicamento y actividad física.
3- METFORMINA 2000 mg/Día o dosis máximas toleradas

CON Síntomas de Hiperglucemia
1- Insulina con o sin METFORMINA

Tratamiento de factores de riesgo asociados
- Sin enfermedad CV y edad menor o igual a 40 años: ROSUVASTATINA 10 mg/Día.
- Con enfermedad CV establecida: ASPIRINA 100 mg/Día y ROSUVASTATINA 20 mg/Día.
- Toma de Presión Arterial
> o = 140/90 confirmadas en 2 visitas: Diagnostico de HTA: LOSARTAN 50 mg - 50 mg/Día.

Sin Enfermedad Cardiovascular o renal establecida
4- METFORMINA 2000 mg/Día + GLICAZIDA LM 30 mg/Día
5- METFORMINA 2000 mg/Día + GLICAZIDA LM 60 mg/Día
6- METFORMINA 2000 mg/Día + GLICAZIDA LM 90 mg/Día
7- INSULINA con o sin METFORMINA, y suspender GLICAZIDA LM

Con Enfermedad Cardiovascular o renal establecida
4- METFORMINA 2000 mg/Día + ISGLT2
5- METFORMINA 2000 mg/Día + ISGLT2 + GLICAZIDA LM 30 mg/Día
6- METFORMINA 2000 mg/Día + ISGLT2 + GLICAZIDA LM 60 mg/Día
7- METFORMINA 2000 mg/Día + ISGLT2 + GLICAZIDA LM 90 mg/Día
8- INSULINA con o sin ISGLT2, suspender GLICAZIDA LM